



54. ÅRGANG | 03 • 2017

3

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Indhold

Hvordan kan man forstå processen i et sandplayforløb, som foregår i en gruppesammenhæng?

På vej mod nye styrkede pædagogiske læreplaner

Når IT bliver et forstyrrende element i undervisningen

Neuroaffektiv udviklingspsykologi og de udviklingsbaserede programmer: NUSSE og Forældre på alle strenge

Måling af børns trivsel i interventionsstudier

"Det bliver hele tiden lidt sværere, kan du mærke det?"

Måling af børns trivsel i interventionsstudier



Psykologer, lærere og pædagoger har i årtier interesseret sig for børn og unges trivsel – herunder deres socio-emotionelle kompetencer – og i de senere år har andre faggrupper så som økonomer og politologer også i stigende grad fattet interesse for dette område. Talrige studier har vist, at trivsel er grundlæggende for, at børn kan udvikle sig på andre områder (Briggs et al., 2012; Curby, Brown, Bassett, & Denham, 2015; Denham & Brown, 2010; Denham, 2006; Payton et al., 2008; Whitcomb & Merrell, 2012), ligesom trivsel i barndommen hænger sammen med bl.a. helbred og uddannelse senere i livet (se fx Center on the Developing Child at Harvard University, 2010; Heckman & Masterov, 2007; Kristoffersen & Smith, 2013; Rutter, Kim-Cohen, & Maughan, 2006). Denne artikel har til hensigt at dele betragtninger og refleksioner omkring måling af børns trivsel i interventionsstudier. Dette gøres ved kort at skitsere teoretiske definitioner på børns trivsel, efterfulgt af en diskussion af praktiske og etiske overvejelser. Afslutningsvis sammenfattes resultaterne fra tre nyere rapporter om måling af børns trivsel, og der gives en kort introduktion til databaser og hjemmesider med relevante tests og spørgeskemaer.

Af Astrid Kiil, ph.d., seniorforsker, Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning,

Nina Madsen Sjö, ph.d., specialist i børneneuropsykologi, Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet og Rambøll Management

Consulting A/S og Maiken Pontoppidan, ph.d., forsker, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Formålet med denne artikel er at give et overblik over, hvilke validerede spørgeskemaer (som kan udfyldes af forældre, lærere, pædagoger eller børn) der findes for forskellige aldersgrupper samt deres tilgængelighed i en dansk kontekst, med henblik på at understøtte valget af spørgeskema i interventionsstudier. Validerede spørgeskemaer bidrager med unik viden ved at kunne kondensere vurderingen af et barns trivsel, samtidig med at de muliggør sammenligning med børn i samme al-

dersgruppe, af samme køn og i en sammenlignelig situation (fx i samme diagnostiske gruppe).

Fremgangsmåden med at kvantificere børns trivsel med udgangspunkt i spørgeskemaer er ikke uden problemer, fx kan det have en afsmittning på den pædagogiske praksis (Gitz-Johansen, 2015). Denne artikel har da heller ikke til formål at argumentere for øget måling af børns trivsel – det sker allerede i betydeligt omfang – men at bidrage til, at valget af spørgeskema i større interventionsstudier er velover-

vejet og baserer sig på opdateret information.

Der findes mange forskellige spørgeskemaer til at måle børns trivsel, og det er derfor vigtigt, at valget er baseret på et bevidst og reflekteret valg, da resultaterne kan få vidtrækkende konsekvenser. På det individuelle niveau kan det have konsekvenser for børns og familiers fremtidige behandlingsforløb, og på et samfundsmæssigt niveau kan det få indflydelse på, hvilke interventioner der udbredes, og hvem de tilbydes til.

Vi håber, at artiklen både kan anvendes af psykologer, der skal rådgive om spørgeskemabrug i større interventionsstudier, og give inspiration til den daglige praksis med vurdering af børns trivsel og udvikling. Dog er det væsentligt at holde sig for øje, at artiklens fokus er måling af udviklingen i trivsel over tid for grupper af børn, og at spørgeskemaer valideret på gruppeniveau ikke nødvendigvis er egnede til screening eller diagnosticering af individer.

Definitioner på børns trivsel

På engelsk anvendes ordet well-being, der kan oversættes til trivsel eller livskvalitet på dansk. Ordet trivsel bliver flittigt brugt, men der findes ikke en enkel teoretisk definition på, hvad børns trivsel er, som forskellige fagdiscipliner er enige om, og som kan omfatte børn i alle aldre (Rees, Bradshaw, Goswami, & Keung, 2006). Der er dog nogle overordnede koncepter og begreber, der er rimeligt veletablerede. Trivsel kan indentificeres ud fra fem forskellige tilgange: den fysiske, den kognitive, den sociale, den økonomiske og den psykologiske tilgang (Pollard &

Lee, 2003) Hvor de første fire især fokuserer på positive aspekter, adskiller den psykologiske tilgang sig ved også at inddrage problemer. Vi fokuserer her på den psykologiske forståelse af trivsel, hvor børns trivsel ofte defineres som deres socio-emotionelle funktion og udvikling, hvilket udmønter sig i adfærd. Denne forståelse af trivsel er særlig relevant i forhold til interventionsstudier med før- og eftermåling. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at acceptabel adfærd i høj grad afhænger af barnets alder, kultur, familieværdier og kontekst (Carter, Briggs-Gowan, & Ornstein Davis, 2004; Squires, Bricker, & Twombly, 2002; Yates et al., 2008).

For små børn i alderen 0-5 år betragtes socio-emotionel udvikling som en fundamental del af deres overordnede helbred og trivsel. For de små børn centrerer de socio-emotionelle kompetencer sig omkring at regulere følelser i interaktion med andre og begyndende interaktion med jævnaldrende (Denham & Brown, 2010). En sund social og følelsesmæssig udvikling defineres af The American Academy of Pediatrics (American Academy of Pediatrics, 2009) som et barns fremspirende evne til: (egen oversættelse)

- at opleve, håndtere og udtrykke det fulde spektrum af positive og negative følelser
- at udvikle tætte, tilfredsstillende relationer til andre børn og voksne
- aktivt at udforske omgivelser og tilegne sig viden

Den store udfordring ved at måle små børns udvikling er, at deres udvikling går meget stærkt og at de ikke udvik-

ler sig i samme tempo eller rækkefølge. Deres signaler kræver desuden mere tolkning end ekspressivt sprog, da de første års følelsesudtryk for mistrivsel sker i form af gråd eller manglende gråd, lyde, udtryk, fagter og fysisk mistrivsel såsom forstoppelse, hvorfor overlappet til fysiske symptomer på sygdom i høj grad er til stede.

For skolebarnet ændrer fokus sig fra socio-emotionel udvikling til socio-emotionelle kompetencer. Kompetencerne bliver centreret omkring følelsesregulering og interaktion med andre, som barnet skal håndtere på en måde, der både tilgodeser kort- og langsigtede behov (Denham, 2015). For den unge bliver det afgørende at kunne etablere tætte forhold til begge køn, at kunne navigere i større grupper samt at bevæge sig mod større selvstændighed. Socio-emotionelle kompetencer for skolebarnet omfatter ifølge the Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL; Payton et al., 2008, p. 6) fem centrale dele (egen oversættelse):

- Selvbevidsthed: håndtere egne følelser, selvværd, interesser og værdier
- Selvforvaltning: håndtere stress, kontrollere impulser, fastholde fokus, udtrykke følelser svarende til omstændigheder/kontekst, sætte og forfølge mål
- Social bevidsthed: udvise empati, anerkende ligheder og forskelle, få mest muligt ud af ressourcer (skole, familie, lokalsamfund)
- Relationsdannelse: etablere og vedligeholde positive relationer, evne til at løse konflikter, modstå gruppepres, søge hjælp hvis nødvendigt

- Beslutningstagning: tage beslutninger på et reflekteret grundlag, være opmærksom på fare, acceptabel social adfærd, respekt for andre og overskue konsekvenser af handlinger, bidrage til skole og samfund.

En anden måde at begrebsoperationalisere trivsel på er at skelne mellem subjektiv (eller hedonisk) trivsel, defineret ved livsglæde og -tilfredshed, og psykisk (eller eudaimonisk) trivsel, der indeholder dynamiske processer såsom personlig udvikling og fremgang (Conti & Heckman, 2012; Pople & Solomon, 2011). Psykisk trivsel dækker over mere komplekse begreber, såsom selvværd, opfattelse af kontrol over eget liv og self-efficacy, der refererer til troen på egne evner til at handle og dermed opnå, hvad man ønsker.

Endelig kan man skelne mellem børns aktuelle trivsel og et mere fremtidsorienteret fokus, hvor trivsel består i at forberede børn til at blive selvforlørgende og livsglade voksne. I den engelsksprogede litteratur beskrives disse to forskellige perspektiver nogle gange som henholdsvis *well-being* og *well-becoming* (Ben-Arieh 2006). Aktuell trivsel og et mere fremtidsorienteret fokus er ikke nødvendigvis gensidigt udelukkende eller modsatrettede begreber. Ben-Arieh & Frønes (2011) argumenterer i deres taksonomi over indikatorer for børns trivsel for, at trivsel skal forstås både som en beskrivelse af nutiden og en forudsigelse af livsbane og udvikling. I denne tilgang til trivsel rummer den samlede trivsel både aktuell og forventet fremtidig trivsel.

Praktiske og etiske overvejelser

Ligesom trivsel teoretisk set kan antage flere former, og den valgte definition kan påvirke, hvilke konklusioner man kommer frem til, så kan det også have betydning, hvilket spørgeskema man vælger til at måle det med. Der er mange spørgeskemaer at vælge imellem, og det kan være svært at beslutte, hvilket der er mest velegnet i den enkelte situation. Nedenstående oversigt giver et overblik over de væsentligste praktiske og etiske overvejelser, der bør gå forud for valget af et specifikt spørgeskema.

Spørgeskemaets teoretiske ramme, dets skalaer og fokus

Det er væsentligt at være bekendt med et spørgeskemas bagvedliggende forståelse af trivsel. Det teoretiske afsæt er oftest beskrevet i en tilhørende manual eller artikel. Spørgeskemaets teoretiske ståsted og skalaer hænger ofte sammen med dets udgivelsestidspunkt, da samfundets aktuelle værdier om adfærd samt det fremherskende teoretiske ståsted i højere eller mindre grad er afspejlet i spørgsmålene. En konkret gennemgang af delskalaer giver indblik i, hvorledes forfatteren har omsat den teoretiske forståelse af trivselsbegrebet.

Spørgsmål kan formuleres med fokus på tilstedeværelse af ressourcer eller problemer. Ordlyden kan have betydning for svarprocenter, og hvad spørgeskemaet indfanger. Eksempelvis kan spørgeskemaer med et strengt problemfokus møde modstand, når de anvendes til børn i normalpopulationen. På den anden side kan der være en risiko for, at spørgeskemaer med udelukkende

ressourcefokuserede spørgsmål overser væsentlige problematikker.

Hvilket aldersinterval spørgeskemaet kan anvendes for

For bedst muligt at kunne vurdere fremgang er det essentielt at vælge et spørgeskema, der kan anvendes både før og efter intervention. Når intervention og eventuelt opfølgning strækker sig over flere år, og en del af børnepopulationen ikke længere kan rummes af spørgeskemaets aldersspænd, opstår der en udfordring. Derfor er spørgeskemaer, der spænder over store aldersintervaller ofte at foretrække i de interventionsstudier, der indsamler data over adskillige år. Det medfører dog den ulempe, at spørgsmålene i spørgeskemaet kan synes irrelevante for bestemte aldersgrupper.

Potentielle respondenter

Nogle spørgeskemaer findes i udgaver, der kan besvares af både forældre, lærere og børn, og i interventionsstudier kan det være en fordel, at der måles på samme fænomen på tværs af sfærer. Det er dog vigtigt at bemærke, at svarprofiler varierer afhængig af, hvem der besvarer, selvom der spørges til det samme. Eksempelvis vurderer lærere og forældre (se fx Kersten et al." med: "(se fx review af Kersten et al. 2016) eller Gresham, Elliott, Cook, Vance, & Kettler (2010). Dette kan skyldes, at forskellige miljøer stiller forskellige krav til barnet, at barnets adfærd er forskelligt afhængig af, hvem det er sammen med, og/eller at den børnegruppe, som læreren eller forældren har som referencenorm, er forskellig. Hvornår børn er gamle nok

til at besvare spørgsmål om egen trivsel afhænger af børnegruppen, såvel som hvilket spørgeskema der benyttes, hvilket stiller krav om en konkret vurdering i den specifikke situation.

Antal items og estimeret administrationstid

Antallet af spørgsmål og den estimerede administrationstid er afgørende for, hvor stor en byrde man pålægger dem, der besvarer spørgeskemaet. Hvor stort et tidsforbrug, der er rimeligt og realistisk, afhænger i høj grad af konteksten, herunder om respondenterne kompenseres for deres arbejde, hvor stort deres udbytte af interventionen er, og om besvarelsen er tvungen eller foregår på frivillig basis. Desuden er der en proportional sammenhæng mellem, hvor lang tid den enkelte vil bruge på spørgeskemabesvarelse, og hvor stort et personligt eller fagligt udbytte den enkelte vil kunne opnå af at deltage i interventionen.

Psykometriske egenskaber

Psykometriske egenskaber såsom reliabilitet og validitet bør indgå som væsentlige kriterier i vurderingen af forskellige spørgeskemaer. Vi henviser til European Federation of Psychologists' Associations (EFPA) for en systematisk gennemgang af, hvad der anses for gode og mindre gode psykometriske egenskaber (Evers et al., 2013). Vurdering af, hvorvidt et skema kan måle progression, bør have særlig høj prioritet i interventionsstudier. Traditionelt er progressionsmåling ikke en egenskab, der har været særlig meget fokus på. Dette har dog ændret sig de senere år inden for interventionsforskningen, se fx gennemgang af progressionsmåling hos National Center on Intensive

Intervention (2016) og Gresham, Cook, et al. (2010).

Svarkategorier

Antallet af og indholdet i svarkategorier har betydning for, hvor lang tid det tager at udfylde et spørgeskema, og hvor nuancerede svarene bliver. Ved beskrivelse af adfærd i interventions-sammenhænge er der ofte behov for viden om, i hvor høj grad en bestemt adfærd er til stede, og i hvilke sammenhænge adfærden optræder, snarere end kategorisk stillingtagen til, om adfærden er til stede eller ej. I forhold til at måle ændringer over tid er skalaer med flere svarkategorier således klart at foretrække frem for ja/nej-kategorier (Marks & LaRosa, 2012).

Om der findes en godkendt dansk udgave

Det vil ofte være et væsentligt kriterie, hvorvidt et spørgeskema findes i en godkendt dansk udgave og dermed umiddelbart kan tages i brug. Hvis det ikke er tilfældet, kontaktes spørgeskemaets forfattere og det relevante forlag med henblik på enten at opnå tilladelse til at oversætte skemaet til engangsbrug i forskningsregi eller at indgå et samarbejde om at udvikle en godkendt oversættelse til det danske marked.

Oversættelse til dansk kan umiddelbart lyde enkelt, men reelt kan det være en omfattende opgave at følge internationale standarder på området (fx Dewolf et al., 2009) og håndtere juridiske forhold omkring rettigheder.

Normering

Normer bruges som vejledning til at sammenligne børns besvarelser med en repræsentativ eller en klinisk popu-

lation. Kvaliteten af normer varierer meget, fx hvorvidt normerne baserer sig på en repræsentativ stikprøve, og hvor mange børn der indgår i hver aldersgruppe. For flere danske spørgeskemaer findes der ikke danske normer, og udgiverne henviser til udenlandske normer. Disse skal dog anvendes med varsomhed grundet kulturelle forskelle og udskiftning af spørgsmål i oversættelsesprocessen (Smedler & Tideman, 2011). Normer kan også bruges til at vurdere, om børnegruppe og spørgeskema passer sammen med henblik på at minimere risikoen for gulv- og loftseffekter.

I randomiserede forsøg, hvor man har en kontrolgruppe, er tilstedeværelsen af danske normer ikke nær så væsentlig som ved undersøgelse af et enkelt individ. Brug af normer er dog fortsat relevant i interventionsstudier, særligt ved simple før-efter-sammenligninger uden kontrolgruppe, da normer indeholder oplysninger om, hvor mange scores et barn går frem som naturlig følge af, at barnet bliver ældre og dermed mestrer mere. Normer med tilhørende kliniske cutoffs kan desuden bruges til at opgøre effekt i forhold til andelen af børn, der oplever en klinisk betydningsfuld ændring eller har kliniske problemer.

Påvirkning af respondenter, herunder etiske forhold

Dem, der besvarer spørgeskemaet, bør ikke vide, om de er i kontrol- eller interventionsgruppen, da dette ville kunne påvirke deres svar. I praksis kan denne adskillelse dog være umulig at implementere i situationer med spørge-

skemaer, der nødvendigvis skal besvares af forældre, pædagoger eller lærere.

Desuden kan nogle spørgsmål, der adresserer meget private forhold, som fx overvejelser om selvmord, starte en følelsesmæssig proces. Spørgeskemaer, der indeholder spørgsmål af denne karakter, egner sig kun til at blive anvendt i sammenhænge, hvor der følges systematisk og professionelt op på bekymrende besvarelser.

Tidligere brug nationalt og internationalt

Mange publikationer om et spørgeskema er en fordel, da en børnepopulations karakteristika samt interventions effekt nemmere kan sammenlignes på tværs af lande og studier, når outcome er evalueret med det samme spørgeskema. Desuden kan det være en fordel ved international publicering, at et internationalt kendt valideret redskab er anvendt fremfor et i bredere kredse ukendt spørgeskema. Det er dog væsentligt at være orienteret om de store kulturelle forskelle på besvarelse af spørgeskemaer, eksempelvis er der meget store variationer i gennemsnitsscores på det psykiatriske skema CBCL på tværs af lande (Achenbach et al., 2008).

Licensforhold, betaling for anvendelse og krav til dataindsamlers kvalifikationer

Nogle spørgeskemaer er copyrightbeskyttede med krav om, at der ikke må foretages ændringer i dem i form af udeladelser af spørgsmål eller subskalaer. Brugen af nogle spørgeskemaer er gratis eller kræver en mindre symbolsk betaling, mens andre har en betragtelig stykpris og kræver indkøb af manual, certificering i form af kursus

eller brug af specifik software. Prisen kan afhænge af, om spørgeskemaet anvendes kommercielt eller ej, ligesom der ofte gives rabat ved indkøb af mange skemaer. Endelig må nogle spørgeskemaer kun indkøbes og/eller anvendes af psykologer eller andre faggrupper med klinisk træning.

Inspirationskilder

Input til overvejelserne om valg af spørgeskema kan fx findes i en række udgivelser (Carter, Godoy, Marakovitz, & Briggs-Gowan, 2012; Haggerty, Elgin, & Woolley, 2011; Humphrey et al., 2011; Kisker, Boller, Jethwani, Nagatoshi, & Sciarrino, 2011; Murrihy, Kidman, & Ollendick, 2010; Ringwalt, 2008; Smedler & Tideman, 2011; Trillingsgaard & Damm, 2012; Washington State Office of Superintendent of Public Instruction, 2008; Whitcomb & Merrell, 2012).

I dette afsnit gennemgår vi desuden tre selvstændige rapporter (Kiil, Arendt, & Rosholm, 2016; Pontoppidan & Niss, 2014; Sjö, 2016), som er udarbejdet af (blandt andre) forfatterne til denne artikel, og som tilsammen gennemgår og vurderer et bredt udvalg af spørgeskemaer til at måle børns trivsel.¹ Disse tre rapporter fokuserer på brug af spørgeskemaer til at måle progression over tid i forbindelse med at undersøge effekt af interventioner, men varierer med hensyn til formål og metode, ligesom de dækker forskellige aldersgrupper.

1 Alle tre rapporter har været underlagt peer-review og kan downloades gratis fra de respektive forskningsinstitutioners hjemmesider (sfi.dk, kora.dk og rockwoolfonden.dk).

Måling af små børns trivsel

Pontoppidan & Niss (2014) vurderer kvaliteten af spørgeskemaer, der kan anvendes til at måle 0-3 årige børns trivsel i en dansk praksis, og giver anbefalinger med hensyn til, hvilke der er de mest velegnede. Børns trivsel forstås i denne rapport som børns socio-emotionelle udvikling og omfatter følgende elementer: 1) opleve, regulere og udtrykke følelser på en passende måde, 2) udvikle tætte relationer til både børn og voksne samt 3) udforske og lære. Rapporten peger særligt på tre velegnede spørgeskemaer. De har alle form af spørgeskemaer, der er letlæselige og kan udfyldes af forældre eller tilsvarende omsorgspersoner på under 10 min.

De tre anbefalede spørgeskemaer er ASQ:SE², DECA-I/T og SEAM. Rapporten konkluderer, at ingen af de tre spørgeskemaer er entydigt bedre end de andre. Hvilket spørgeskema man bør vælge i en specifik situation, afhænger af, hvad spørgeskemaet mere præcist skal bruges til.

Der er udført en systematisk søgning i internationale databaser suppleret med andre søgninger. I alt 2.037 artikler er blevet screenet for relevans; heraf er 262 undersøgt nærmere. Dette førte til identifikation af 226 spørgeskemaer, hvoraf 30 er beskrevet nærmere og vurderet. Afslutningsvis er fire spørgeskemaer blevet beskrevet, vurderet og sammenlignet. Vurderin-

2 Vi gør opmærksom på, at der siden publiceringen af rapporten er kommet en ny udgave: ASQ:SE-2, der adskiller sig fra ASQ:SE ved at have en særskilt version til børn på 1 måned og ved at være udvidet med spørgsmål, der skal opfange tidlige tegn på autisme.

FAKTABOKS	
<i>Forkortelse</i>	<i>Fulde navn</i>
ASQ-SE	Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional
BASC-2	Behavior Assessment System for Children, Second Edition
CBCL	Child Behavior Checklist
BASC-2 BESS	BASC-2 Behavioral and Emotional Screening System
DECA-I/T	Devereux Early Childhood Assessment for Infants and Toddlers
KIDSCREEN	KIDSCREEN
SDQ	Strengths & Difficulties Questionnaires
SEAM	Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure, Research Edition
SSRS	Social Skills Rating System
WHO-5	World Health Organization 5-item Well-Being Index

gen af spørgeskemaer bygger på de konkrete spørgsmål og skalaer, manualer, oplysninger fra udgivere og hjemmesider, publiceret materiale om spørgeskemaerne og information fra udviklerne. Centrale kriterier for udvælgelsen af spørgeskemaerne har været: Spørgeskemaet skal spænde over minimum 2 års aldersinterval og skal indeholde spørgsmål til børn under 24 måneder. Der skal være spørgsmål til socio-emotionel udvikling for alle aldersgrupper (0-3 år). Spørgeskemaet skal indeholde ressourcefokuserede spørgsmål frem for problemfokuserede, skal kunne udfyldes på højst 20 minutter (60 spørgsmål) og skal have mere end to svarkategorier.

Måling af trivsel i interventionsstudier af børn i skolealderen

Sjö (2016) formidler et overblik over egnede spørgeskemaer med lærer- og elevbesvarelse til at måle effekten af en klassebaseret indsats til børn mellem 8 og 12 år.

Rapporten gennemgår fordele og ulemper ved 13 spørgeskemaer og rangordner dem i henhold til deres kvaliteter i forhold til at måle effekten af en klassebaseret indsats, og hvor formålet er at styrke det socio-emotionelle område. Følgende faktorer indgår i bedømmelsen af de enkelte spørgeskemaer: Aldersmålgruppen, skalaernes indhold, psykometriske egenskaber, udbredelse, respondenttyper, gruppebesvarelse, besvarelsestid og normer. De tre højest prioriterede skemaer er SSRS, BASC-2 og SDQ.

Rapportens inklusionskriterier er danske spørgeskemaer, der måler aspekter af det sociale område, det emotionelle område eller psykosocial trivsel, og er egnede til at vurdere skoleelever inden for normalområdet eller på grænsen til normalområdet. Desuden skal skemaet have en maksimal besvarelsestid på 20 min. for lærere og 30 min. for elever samt være valideret og have et eller flere valideringsstudier publiceret i videnskabelige tidsskrifter. Spørgeskemaer er ekskluderet, hvis skemaets hovedformål er at måle 'Qua-

lity of Life', at screene/diagnosticere en afgrænset problemstilling inden for et diagnostisk område som fx autisme-spektrumsforstyrrelser eller at måle relativt dårligt fungerende børns udvikling. På denne baggrund er otte spørgeskemaer ekskluderet.

Rapportens bilag er udarbejdet som et opslagsværk, hvor væsentlige karakteristika for de anbefalede spørgeskemaer er opsat i tabelformat, så de er nemme at sammenligne indbyrdes. Af tabellen fremgår pris, måleområde inkl. subskalaer, antal spørgsmål, udførelsestid, respondenter, alder, udbredelse, få psykometriske egenskaber og tilgængelige normer.

Måling af trivsel på tværs af interventionsstudier

Kiil, Arendt & Rosholm (2016) identificerer forslag til spørgeskemaer, der er velegnede som mål af børns trivsel, på tværs af et bredt udvalg af studier af børn og unge. Børns trivsel forstås i denne rapport bredt og dækker over livskvalitet, psykisk trivsel og socio-emotionel funktion.

Rapporten peger på syv spørgeskemaer, der er særligt velegnede til at måle børns trivsel på tværs af et bredt udvalg af studier af børn og unge: Et skema til måling af livskvalitet (KID-SCREEN), et skema til måling af positiv psykisk trivsel (WHO-5), tre kandidater til måling af socio-emotionel funktion for små børn (DECA-I/T, ASQ:SE og SEAM) og to for større børn (SDQ og BASC-2 BESS). De syv spørgeskemaer er beskrevet og vurderet med udgangspunkt i manualer, oplysninger fra udgivere og hjemmesider samt publiceret materiale om spørgeskemaerne.

Potentielle spørgeskemaer blev identificeret ved at indhente forslag fra projektlederne i Trygfondens Børneforskningscenter samt andre tilknyttede eksperter med omfattende forskningserfaring inden for børn og ungeområdet. Eksperterne foreslog flere potentielle spørgeskemaer og henviste til testkataloger fra forlag og eksisterende litteraturoversigter. Alle forslag blev forfulgt, og en indledningsvis screening førte til, at 27 spørgeskemaer blev udvalgt, hvoraf 25 er beskrevet nærmere og vurderet.

Centrale kriterier for udvælgelsen af spørgeskemaerne var: Spørgeskemaet skal måle en form for trivsel. Der må så vidt muligt ikke indgå spørgsmål, som kan starte en terapeutisk proces hos barnet eller virke stødende. For aldersgrupper og områder, hvor der findes et skema, som er oversat til dansk, foretrækkes dette fremfor eventuelle alternativer, som (endnu) ikke findes i en dansk udgave.

Databaser og hjemmesider med fokus på test og spørgeskemaer

En begrænsning ved de gennemgåede rapporter er, at der er tale om øjebliksbilleder med udgangspunkt i udgivelsestidspunktet. Måling af børns trivsel er imidlertid et område i hastig udvikling, idet der løbende kommer nye spørgeskemaer til, ligesom eksisterende spørgeskemaer udkommer i nye og reviderede udgaver. I det følgende angives derfor nogle databaser og hjemmesider, der er gode kilder til at indhente opdateret information om tilgængelige tests og spørgeskemaer. Nogle er gratis tilgængelige for alle, mens der er begrænset adgang til andre.

Det norske Regionscenter for barn og unges psykiske helse driver hjemmesiden og det elektroniske tidsskrift **PsykTestBarn** (<http://www.psyktestbarn.no>), der udgiver oversigtsartikler omhandlende spørgeskemaer og tests, der anvendes i Norge. Deres rapporter gennemgår psykometriske egenskaber og brug i Danmark, Norge og Sverige.

Den Amerikanske Psykolog Forening (APA) står bag databasen **PsycTESTS** (<http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/>), der indeholder både gratis og licensbeskyttede tests, observationsredskaber og spørgeskemaer samt oversigtsartikler om disse. PsycTESTS er en relativt set lille database, men indeholder unik information.

APA udgiver også **PsycINFO** (<http://www.apa.org/pubs/databases/psyc-tests/>), der er en stor tværfaglig database inden for psykologi og socialvidenskab. Det er muligt at søge meget målrettet ved fx kun at få vist artikler, der omtaler et specifikt spørgeskema eller et specifikt emne i artiklers metodeafsnit ved brug af søgefunktionen “tests and measures”. En alternativ søgestrategi er at afgrænse søgningen til artikler, hvor en bestemt test eller et bestemt spørgeskema er nævnt i andre artiklers litteraturliste.

Endelig tilbyder adskillige amerikanske forlag **webinars**, hvor deres spørgeskemaer beskrives. Der vises eksempler på spørgeskemaet og de psykometriske variable, og det teoretiske ophav gennemgås.

Perspektivering

I større interventionsstudier kan man ofte med fordel anvende spørgeskemaer til at måle børns trivsel. Dette gæl-

der både praktiske og ressourcemæssige årsager, samt fordi en spørgeskemabesvarelse afspejler kondenseret viden om adfærd over tid i modsætning til et øjebliksbillede indsamlet i en testsituation eller ved observation. Hvilket spørgeskema, der er det bedste valg i et konkret projekt, afhænger imidlertid af en række forhold, herunder interventionens fokus, intensitet og varighed, ligesom der kan være et ønske om at kunne sammenligne resultater på tværs af studier.

Teknologien til at støtte op omkring måling af børns trivsel udvikler sig hastigt, fx i form af webspørgeskemaer samt brug af tablets og mobiltelefoner til dataindsamling, og vi forventer, at dette vil bidrage til et endnu større fokus på området fremover. Den nye teknologi gør det nemmere at indsamle data regelmæssigt, fx via SMS, ligesom den åbner op for nye muligheder for at udvikle adaptive spørgeskemaer.

Endelig er det vigtigt, at politikere såvel som forskere og fagprofessionelle har for øje, at man ikke bare skal måle for målingens skyld, idet børns trivsel ikke bliver bedre, fordi den bliver målt. Måling skal nødvendigvis følges op af støtte eller intervention til de børn, der viser sig at være i mistrivsel, eller bidrage til udvikling af praksis for at have en egentlig værdi.

Referencer

Achenbach, T. M., Becker, A., Döpfner, M., Heiervang, E., Roessner, V., Steinhausen, H.-C., & Rothenberger, A. (2008). Multicultural assessment of child and adolescent psychopathology with ASEBA and SDQ instruments: research findings, applications, and future directions. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Al-*

- lied Disciplines*, 49(3), 251–75. <http://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01867.x>
- American Academy of Pediatrics. (2009). *The Social Emotional Development of Young Children*. Washington, DC: National Healthy Start Association.
- Briggs, R. D., Stettler, E. M., Silver, E. J., Schrag, R. D. a., Nayak, M., Chinitz, S., & Racine, a. D. (2012). Social-Emotional Screening for Infants and Toddlers in Primary Care. *Pediatrics*, 129(2), e377–e384. <http://doi.org/10.1542/peds.2010-2211>
- Carter, A. S., Briggs-Gowan, M. J., & Ornstein Davis, N. (2004). Assessment of young children's social-emotional development and psychopathology: recent advances and recommendations for practice. *Journal of Child Psychology & Psychiatry*, 45(1), 109–134.
- Carter, A. S., Godoy, L., Marakovitz, S. E., & Briggs-Gowan, M. J. (2012). Parent Reports and Infant-Toddler Mental Health Assessment. In C. H. Zeanah Jr (Ed.), *Handbook of Infant Mental Health* (pp. 233–251). New York: Guilford Press.
- Center on the Developing Child at Harvard University. (2010). *The Foundations of Lifelong Health Are Built in Early Childhood*. Cambridge, MA: Harvard University.
- Conti, G., & Heckman, J. J. (2012). The Economics of Child Well-Being. IZA, (Discussion Paper No. 6930).
- Curby, T. W., Brown, C. A., Bassett, H. H., & Denham, S. A. (2015). Associations Between Preschoolers' Social-Emotional Competence and Preliteracy Skills. *Infant and Child Development*, 24(5), 549–570. <http://doi.org/10.1002/icd.1899>
- Denham, S. A. (2006). Social-Emotional Competence as Support for School Readiness: What Is It and How Do We Assess It? *Early Education & Development*, 17(1), 57–89. http://doi.org/10.1207/s15566935eed1701_4
- Denham, S. A. (2015). Assessment of SEL in educational contexts. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg, & T. P. Gullotta (Eds.), *Handbook of Social and Emotional Learning* (pp. 285–300). New York: The Guilford Press.
- Denham, S. A., & Brown, C. (2010). "Plays Nice With Others": Social-Emotional Learning and Academic Success. *Early Education & Development*, 21(5), 652–680. <http://doi.org/10.1080/10409289.2010.497450>
- Dewolf, L., Koller, M., Velikova, G., Johnson, C., Scott, N., & Bottomley, A. (2009). *EORTC Quality of Life Group translation procedure*. Brussels: EORTC Quality of Life Group.
- Evers, A., Hagemester, C., Høstmælingen, A., Lindley, P., Muñoz, J., & Sjöberg, A. (2013). *EFPA Review Model for the description and evaluation of psychological and educational tests*. Approved by the EFPA General Assembly, 13-07-2013.
- Gitz-Johansen, T. (2015). Når testning griber ind i pædagogikken. *Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift*, 52(3), 44–62.
- Gresham, F. M., Cook, C. R., Collins, T., Dart, E., Rasetshwane, K., Truelson, E., & Grant, S. (2010). Developing a change-sensitive brief behavior rating scale as a progress monitoring tool for social behavior: An example using the Social Skills Rating System-Teacher Form. *School Psychology Review*, 39(3), 364–369.
- Gresham, F. M., Elliott, S. N., Cook, C. R., Vance, M. J., & Kettler, R. (2010). Cross-informant agreement for ratings for social skill and problem behavior ratings: an investigation of the Social Skills Improvement System-Rating Scales. *Psychological Assessment*, 22(1), 157–166. <http://doi.org/10.1037/a0018124>
- Haggerty, K., Elgin, J., & Woolley, A. (2011). *Social-Emotional Learning Assessment Measures for Middle School Youth*. Social Development Research Group. University of Washington: Raikes Foundation.
- Heckman, J. J., & Masterov, D. V. (2007). The Productivity Argument for Investing in Young Children. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 29(3), 446–493.
- Humphrey, N., Kalamhouka, a., Wigelsworth, M., Lendrum, a., Deighton, J., & Wolpert, M. (2011). Measures of Social and Emotional Skills for Children and Young People: A Systematic Review. *Educational and Psychological Measurement*, 71(4), 617–637. <http://doi.org/10.1177/0013164410382896>
- Kersten, P., Czuba, K., McPherson, K., Dudley, M., Elder, H., Tauroa, R., & Vandal, A. (2016). A systematic review of evidence for the psychometric properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire. *International Journal of Behavioral Development*, 40(1), 64–75. <http://doi.org/10.1177/0165025415570647>

- Kiil, A., Arendt, J. N., & Rosholm, M. (2016). *Measuring Child Well-being An overview of potential measurement instruments*. Copenhagen: KORA og Trygfondens Børneforskningscenter.
- Kisker, E., Boller, K., Jethwani, V., Nagatoshi, C., & Sciarrino, C. (2011). *Resources for Measuring Services and Outcomes in Head Start Programs Serving Infants and Toddlers*. Mathematica Policy Research. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services.
- Kristoffersen, J., & Smith, N. (2013). Gender Differences in the Effects of Behavioral Problems on School Outcomes. *IZA*, (Discussion Paper No. 7410).
- Marks, K. P., & LaRosa, a. C. (2012). Understanding Developmental-Behavioral Screening Measures. *Pediatrics in Review*, 33(10), 448–458. <http://doi.org/10.1542/pir.33-10-448>
- Murrihy, R. C., Kidman, A. D., & Ollendick, T. H. (2010). *Clinical handbook of assessing and treating conduct problems in youth*. New York: Springer.
- National Center on Intensive Intervention. (2016). Academic Progress Monitoring. Retrieved September 13, 2016, from <http://www.intensiveintervention.org/chart/progress-monitoring>
- Payton, J., Weissberg, R. P., Durlak, J. A., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., Schellinger, K. B., & Pachan, M. (2008). The Positive Impact of Social and Emotional Learning for Kindergarten to Eighth-Grade Students: Technical Report – Findings from Three Scientific Reviews. Chicago, IL: *Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)*, (December), 12.
- Pollard, E. L., & Lee, P. D. (2003). Child well-being: A systematic review of the literature. *Social Indicators Research*, 61(1), 59–78.
- Pontoppidan, M., & Niss, N. K. (2014). *Instrumenter til at måle små børns trivsel*. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
- Pople, L., & Solomon, E. (2011). *How happy are our children: measuring children's well-being and exploring economic factors*. The Children's Society.
- Rees, G., Bradshaw, J., Goswami, H., & Keung, A. (2006). *Understanding children's well-being: A national survey of young people's well-being*. London: The Children's Society.
- Ringwalt, S. (2008). *Developmental Screening and Assessment Instruments*. Chapel Hill, NC: National Early Childhood Technical Assistance Center.
- Rutter, M., Kim-Cohen, J., & Maughan, B. (2006). Continuities and discontinuities in psychopathology between childhood and adult life. *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 47(3-4), 276–295. <http://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01614.x>
- Sjö, N. M. (2016). *Hvilke validerede spørgeskemaer er egnede til at måle effekt af en intervention, der har fokus på det socio-emotionelle område?* København: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
- Smedler, A., & Tideman, E. (2011). *At teste børn og unge: om testmetoder i den psykologiske undersøgelse*. København: Hans Reitzels Forlag.
- Squires, J. K., Bricker, D., & Twombly, E. (2002). *The ASQ-SE user's guide : for the ages & stages questionnaires, social-emotional. A Parent-Completed, Child-Monitoring System for Social-Emotional Behaviors*. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Pub. Co.
- Trillingsgaard, A., & Damm, D. (2012). *Spørgeskemaer i klinisk praksis med børn og unge*. København: Dansk Psykologisk Forlag.
- Washington State Office of Superintendent of Public Instruction. (2008). *A Guide to Assessment in Early Childhood: Infancy to Age Eight*. Washington: Washington State Office of Superintendent of Public Instruction.
- Whitcomb, S. A., & Merrell, K. W. (2012). *Behavioral, social, and emotional assessment of children and adolescents*. New York: Routledge.
- Yates, T., Ostrosky, M. M., Cheatham, G. A., Fetting, A., Shaffer, L., & Santos, R. M. (2008). *Research Synthesis on Screening & Assessing Social-Emotional Competency*. Nashville, TN: Center on the Social Emotional Foundations for Early Learning, Vanderbilt University.